

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818431-14.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADA: ARLENE JULIE OLIVEIRA DE SOUZA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ONCOPRESERVAÇÃO DE ÓVULOS. INDICAÇÃO MÉDICA PARA PACIENTE COM CÂNCER. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência para determinar o custeio de procedimento de oncopreservação de óvulos, indicado a paciente jovem diagnosticada com câncer colorretal, com vistas a prevenir infertilidade decorrente da quimioterapia.

II. Questão em discussão

1. A controvérsia consiste em saber se é legítima a determinação judicial de obrigar o plano de saúde a custear procedimento de congelamento e armazenamento de óvulos prescrito por médico assistente, ainda que não incluído no rol da ANS nem expressamente previsto em contrato.

III. Razões de decidir

1. A decisão agravada encontra respaldo no art. 35-F da Lei nº 9.656/1998, que impõe aos planos de saúde a cobertura de ações necessárias à prevenção e recuperação da saúde.
2. O Superior Tribunal de Justiça (REsp 1815796/RJ) reconhece que a oncopreservação, para evitar infertilidade em pacientes submetidas a quimioterapia, configura obrigação contratual, e não técnica de reprodução assistida.
3. A recusa do plano é ilegítima e contrária ao CDC (arts. 4º e 51), conforme Súmula 608 do STJ.
4. A Lei nº 14.454/2022 prevê a possibilidade de cobertura de tratamentos fora do rol da ANS, desde que comprovada sua eficácia com base em evidências científicas.
5. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), é cabível a manutenção da tutela concedida.

IV. Dispositivo e tese

1. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a recusa de plano de saúde à cobertura de procedimento de criopreservação de óvulos prescrito a paciente oncológica fértil, como medida de prevenção à infertilidade

decorrente da quimioterapia.

2. O rol de procedimentos da ANS possui natureza taxativa mitigada, admitindo exceções quando comprovada a necessidade médica e a eficácia do tratamento."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 300, 932, IV, "a"; Lei nº 9.656/1998, art. 35-F; Lei nº 14.454/2022, art. 10, §13; CDC, arts. 4º, 51.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1815796/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 26.05.2020, DJe 09.06.2020;

STJ, Súmula 608.

-

DECISÃO MONOCRÁTICA

-

Trata-se de **Agravo de Instrumento** interposto por **UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO** contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 0867402-97.2025.8.14.0301, ajuizada por **ARLENE JULIE OLIVEIRA DE SOUZA**,

A decisão agravada deferiu pedido de tutela antecipada para compelir a operadora de saúde a autorizar e custear, no prazo de 48 horas, o procedimento de coleta, congelamento e armazenamento de óvulos (oncopreservação), incluindo os custos com medicamentos, honorários médicos, materiais e internação, se necessária, sob pena de multa diária no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais (ID 29659369), a Agravante alega, em síntese: (i) ausência de obrigação contratual de cobertura para o procedimento de oncopreservação de óvulos; (ii) inexistência de previsão no rol da ANS, que reputa de caráter taxativo, mesmo após a edição da Lei nº 14.454/2022; (iii) ausência de demonstração de urgência ou da probabilidade do direito; (iv) risco de efeito multiplicador de demandas semelhantes; e (v) existência de periculum in mora inverso. Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, para indeferir a antecipação dos efeitos da tutela.

Não consta nos autos, até o momento, a apresentação de contrarrazões pela parte Agravada.

É o relatório.

VOTO.

Com efeito, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao comando legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado refere-se à legalidade da decisão que determinou à operadora de plano de saúde a autorização e custeio de procedimento de oncopreservação (congelamento de óvulos), prescrito por médico assistente à paciente diagnosticada com adenocarcinoma colorretal, em razão dos riscos de infertilidade associados ao tratamento quimioterápico.

Compulsando os autos, entendo estar demonstrada que a Agravada necessita do tratamento acima citado, nos termos do laudo médico (ID 148553242 – PJE 1º GRAU – Processo nº 0867402-97.2025.8.14.0301), bem como está demonstrada a solicitação ao plano de saúde (ID 148550699 - PJE 1º GRAU – Processo nº 0867402-97.2025.8.14.0301).

Com efeito, observa-se que o Juízo *a quo* agiu de forma acertada, uma vez que os requisitos para o deferimento da tutela antecipada estão plenamente caracterizados, haja vista que a operadora de saúde possui responsabilidade quanto ao tratamento indicado para a recorrida.

Não se trata de responsabilizar as operadoras de planos de saúde, pela saúde integral dos cidadãos, obrigação do Estado, mas, sim, de responsabilizá-las pelas obrigações contratualmente assumidas, das quais não podem se desvincular a qualquer pretexto.

Ademais, conforme Súmula 608 do STJ, a relação jurídica entre a seguradora e o segurado de plano de saúde é consumerista, razão pela qual a cláusula contratual que limita a cobertura de procedimentos médicos aos constantes no rol da ANS coloca o consumidor em flagrante desvantagem, devendo ser considerada abusiva por afronta aos artigos 4º, 51 do CDC.

Em que pese o argumento da Recorrente de que o procedimento não está previsto no Rol de Procedimentos da ANS, nem no contrato firmado entre as partes, tem-se que a jurisprudência pátria – inclusive do Superior Tribunal de Justiça – vem assentando que o referido rol, conquanto mantenha natureza taxativa, admite exceções quando presentes critérios específicos, mormente quando há comprovação da necessidade médica do procedimento e sua eficácia terapêutica.

Assim, a recusa é ilegítima, devendo o plano de saúde custear os medicamentos indicados pelo médico.

O procedimento de criopreservação de óvulos prescrito com o fim de prevenir a infertilidade em pacientes submetidas à quimioterapia não se confunde com técnica de reprodução assistida – cuja cobertura contratual pode ser afastada. Trata-se, na verdade, de procedimento terapêutico voltado à preservação da função reprodutiva como medida de mitigação dos efeitos adversos previsíveis do tratamento da doença coberta (câncer), à luz do disposto no art. 35-F da Lei nº 9.656/1998:

“Art. 35-F. A assistência a que alude o art. 1º desta Lei compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes”.

Em reforço, é de se registrar o entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1815796/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, no qual se reconheceu que, em casos de mulheres férteis, submetidas a tratamento oncológico com risco de falência ovariana, a cobertura da criopreservação de óvulos configura-se como obrigação contratual derivada da obrigação maior de preservar a saúde, nos moldes do art. 35-F da Lei 9.656/1998. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. PLANO DE SAÚDE . TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO PARA CÂNCER DE MAMA RECIDIVO. PROGNÓSTICO DE FALÊNCIA OVARIANA COMO SEQUELA DA QUIMIOTERAPIA. **PLEITO DE CRIOPRESERVAÇÃO DOS ÓVULOS. EXCLUSÃO DE COBERTURA . RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS 387/2016. NECESSIDADE DE MINIMIZAÇÃO DOS EFEITOS COLATERAIS DO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. PRINCÍPIO MÉDICO "PRIMUM, NON NOCERE".**

OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO ATÉ À ALTA DA QUIMIOTERAPIA NOS TERMOS DO VOTO DA MIN .a NANCY ANDRIGHI. 1. Controvérsia acerca da cobertura de criopreservação de óvulos de paciente oncológica jovem sujeita a quimioterapia, com prognóstico de falência ovariana, tornando-a infértil. 2 . Nos termos do art. 10, inciso III, da Lei 9.656/1998, não se inclui entre os procedimentos de cobertura obrigatória a "inseminação artificial", compreendida nesta a manipulação laboratorial de óvulos, dentre outras técnicas de reprodução assistida (cf. RN ANS 387/2016) . 3. Descabimento, portanto, de condenação da operadora a custear criopreservação como procedimento inserido num contexto de mera reprodução assistida. 4. Caso concreto em que se revela a necessidade atenuação dos efeitos colaterais, previsíveis e evitáveis, da quimioterapia, dentre os quais a falência ovariana, em atenção ao princípio médico "primum, non nocere" e à norma que emana do art . 35-F da 9.656/1998, segundo a qual a cobertura dos planos de saúde abrange também a prevenção de doenças, no caso, a infertilidade. 5. Manutenção da condenação da operadora à cobertura de parte do procedimento pleiteado, como medida de prevenção para a possível infertilidade da paciente, cabendo à beneficiária arcar com os eventuais custos do procedimento a partir da alta do tratamento quimioterápico, nos termos do voto da Min .a NANCY ANDRIGHI. 6. Distinção entre o caso dos autos, em que a paciente é fértil e busca a criopreservação como forma de prevenir a infertilidade, daqueles em que a paciente já é infértil, e pleiteia a criopreservação como meio para a reprodução assistida, casos para os quais não há obrigatoriedade de cobertura. 7 . RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1815796 RJ 2019/0150440-1, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2020)

Ademais, a Lei nº 14.454/2022 introduziu o §13 ao art. 10 da Lei nº 9.656/98, prevendo expressamente que procedimentos fora do rol da ANS podem ser autorizados quando preenchidos determinados requisitos:

“§13. É obrigatória a cobertura de tratamento ou procedimento, ainda que não incluído no rol de que trata o §4º deste artigo, quando:

I – houver comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico;

II – existirem recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) ou, no mínimo, por um órgão de avaliação de tecnologias em saúde com renome internacional, desde que aprovadas também para seus nacionais.”

Neste sentido, sendo a saúde e a vida direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, não há razões plausíveis para a reforma do decisum, não podendo o Agravante se eximir de cumprir o que determina a decisão agravada, devendo providenciar o atendimento correspondente a situação do recorrido envolvida no presente caso.

No caso sob exame, restou evidenciada a prescrição médica do procedimento, que visa preservar a fertilidade da paciente – jovem e ainda em idade fértil – e mitigar os efeitos deletérios previsíveis da quimioterapia. A negativa de cobertura, portanto, além de implicar violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana,

configura conduta abusiva nos termos do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, aplicado aos contratos de plano de saúde conforme a Súmula nº 608 do STJ.

Desta forma, a presunção é que há sim falha na prestação do serviço e que deve ser mantida a tutela até o pronunciamento de mérito sobre o tema.

Demonstrada a probabilidade do direito e o risco à saúde do menor, considero presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência e escorreita a decisão combatida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **CONHEÇO** e **NEGO PROVIMENTO** ao recurso, nos termos da fundamentação.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora